就直接進入委員會裡面，這樣可以嗎，局長？

社會局盧局長禹璁：

是，他們就會有代表了。

婦女及兒童少年福利科許科長乃文：

跟議座報告，因為我們的組織要點裡面是有限制每個類別的人數，所以剛剛議座關心的是民間機構或團體的代表席次，依照要點是2到3人，目前有2名，其中1位是褓姆公會的副理事長，至於托嬰中心的代表目前用這個類別來看是可以在遴選出1名。

林議員冠維：

就是說目前托嬰中心的代表是2位，還可以再加1位，對嗎？

婦女及兒童少年福利科許科長乃文：

對。

林議員冠維：

這邊要跟局長反映，我接到的陳情不是這樣子，是說托嬰中心目前連1位代表都沒有。

社會局盧局長禹璁：

1位的話，我們再來協調看要哪一位進來。

林議員冠維：

好，這邊再麻煩局長，因為他們的聲音想要表達給我們的社會局，我想要有一個代表委員在裡面開會，比較可以充分的溝通討論，這個非常重要，再麻煩局長這邊，看結論怎樣再回復本席。

社會局盧局長禹璁：

好。

林議員冠維：

謝謝局長。

主席：（李議員文俊）

請陳皇宇議員發言。

陳議員皇宇：

感謝主席。先感謝局長，你的簡報做得很仔細，只是忘記放了那一張，因為黃肇輝議員也有質疑，也就是大家對你的表現跟所有東西都OK，只是大家會疑惑我們臺南市做那麼好，怎麼可能實際上是這樣。有一個部分我要特別講，就是行動醫院，行動醫院的業績，就是人數，我們去偏鄉或是哪裡，人數有增加嗎?我想請問局長，今年跟去年比較，行動醫院去偏鄉的人數有增加嗎？

衛生局李局長翠鳳：

我們今年還是有2萬5,000多，個別的統計請科長提一下。

國民健康科黃科長琬淇：

我們會依照需求，還是有偏鄉的部分，例如龍崎會有龍湖宮的部分，歸仁也會有一些偏鄉的部分。

陳議員皇宇：

其實這個也不能算業績，照顧偏鄉的話，他的人數一定不會那麼多人，我只是想知道受檢的總人數有沒有增加？

國民健康科黃科長琬淇：

一年大概可以做到3萬人。

陳議員皇宇：

跟去年做比較有沒有增加？

國民健康科黃科長琬淇：

目前差不多，沒有什麼特別增加。因為行動醫院只是一個區塊，我們還是希望民眾…

陳議員皇宇：

我會這樣請教是因為行動醫院的醫療人員一直的增加服務的項目，包含驗光師等其他師資，我們也看到你們有用AI去做骨密的部分，從以前很簡陋的，到現在有AI的判讀，AI的判讀或許也是一個可以讓更多人參與行動醫院篩檢的，不管是癌篩或是其他的篩檢，像我們今天的亮點是AI篩檢評估值幾乎跟躺在醫院那裡做是一樣的，你可不可以解釋一下這個部分？

衛生局李局長翠鳳：

有關於我們現在跟宏碁智醫的合作，因為這個影像是有經過TFDA認證的，我們篩檢出來之後的異常率，這些異常的個案再到醫院去做，其實跟醫院的結果可以吻合9成以上，表示它的準確性蠻高的。

陳議員皇宇：

也就是說，在行動醫院裡面不只是只有癌篩跟疫苗的施打，其實我們一直在UPDATE新的，那新的部分你要特別讓大家知道，其實像這樣的骨密設施在診所是要自費的，他沒有辦法申報，但是在醫院端骨科醫師或骨外科醫師是可以申報的，也就是說把這個拉出來的話，在診所做可能就要自費幾千元，也就是它的價值性就比較高，所以在推廣明年度的行動醫院的部分，我想衛生局應該是要把你的特色性拉出來讓大家知道，實行了20幾年之後，每年又多做了什麼，我想人數就會一直提升，尤其偏鄉都是長輩，又尤其是常常在勞作的婦女，很多都是骨密，以前躺在那裡還要做髖關節至少30分鐘，現在AI判讀雖然不是醫療器材，但是準確率可以達到90%。

衛生局李局長翠鳳：

對，準確率很高，所以它做篩檢很好。

陳議員皇宇：

我覺得局長做的非常好，但是就差在promotion。

衛生局李局長翠鳳：

好，我們努力來promotion。

陳議員皇宇：

好，我再跟你請教健康心理衛生中心，我們其實在關廟有個地點要做，大概進度到哪裡？其實鄉親都想知道。

衛生局李局長翠鳳：

應該是今年年底就要成立，因為我們希望他們在上下的時候可以有個電梯可以使用到二樓，這個電梯正在做，預計今年年底這個地方就要開幕。

陳議員皇宇：

確定不會再延宕嗎？

心理健康科陳科長月英：

目前我們外觀已經快要完成了，再來就是內部的裝潢，所以我們預估是年底以前就會完成。

陳議員皇宇：

其實爭取到南關線這個地方真的不容易，其他區都一直想要爭取，但是剛好我們有地方可以做，所以應該是可以協助，學校裡面也有心衛的配合，我想這個部分擴出去整個南關線的話是有非常大的益處的，所以進度要麻煩局長還有科長一定要加強，因為現在抑鬱症或憂鬱的個案其實蠻多的，如果有加強的話，我相信自殺防護員那些都有一定的加乘效果，謝謝。

衛生局李局長翠鳳：

好，謝謝。

主席：（李議員文俊）

上午的議程到此結束，下午1點30分繼續開會。

主席：（陳議員皇宇）

下午會議開始，繼續環保衛生部門衛生局、社會局業務報告及質詢，依照議事日程，下午到5點30分，預定分別在2點30分、3點30分、4點30分各休息10分鐘，以上若無意見，先請李偉智議員發言。

李議員偉智：

謝謝主席。就教社會局長，我們早上討論的長輩的友善餐廳，這個部分參考其他縣市，比較都會型的餐飲系統比較密集，如果長輩有3人或5人同行可以給他一些折扣優惠，其實可以做一些敬老餐廳的標章，這樣的話可能年輕人也蠻喜歡光顧的，對他們來講可以盡一些社會責任，這樣的標章我覺得對你的業務費用來講可能沒有增加很多。

社會局盧局長禹璁：

對，沒錯。

李議員偉智：

可是對長輩在都市或餐廳比較密集的區域很有效益，而且他可以3人同行7折或8折等等的。

社會局盧局長禹璁：

這個我們來規劃來做。

李議員偉智：

對，他們的餐廳通道等等可能對長輩比較友善，我們都要慢慢適應高齡化社會的到來，好不好。

社會局盧局長禹璁：

好。

李議員偉智：

局長，殘障手冊我們臺南市目前列管的人有多少？

社會局盧局長禹璁：

10萬人左右。

李議員偉智：

也不少，占了我們臺南市市民蠻大的比重，因為殘障就業受到一些障礙，這樣的狀

況你們有掌握到嗎？他可能因為某方面的缺陷，導致職場上應徵有困難，這個部分我勞工局會問，但在這樣就業困難的狀況下，社會局有什麼積極的作為。除了給她一些補助、輔具還有一些資源以外，工作還是最基本的，給他一個好的工作養他自己，他也一直在講他的工作能力是沒問題的，他雖然外觀有一些缺陷，但還是很正面的，還是以積極樂觀的態度想要進入職場，這個部分，難道我們在就業的機制上沒有比較具體的做法嗎？

社會局盧局長禹璁：

有，我們有具體的做法，請科長回答。

身心障礙福利科洪科長筱涵：

跟議座說明，我們目前在身障就業的部分都有身障需求的評估人員，身障者在取得身障證明的時候就會有需求人員先做評估。

李議員偉智：

你講的是程序，可是結果呢？

身心障礙福利科洪科長筱涵：

他評估的時候就會看身障者，如果他是有就業意願也有就業能力的話，我們就會在這個時候幫他轉介勞工局的就業服務。

李議員偉智：

之後有追蹤嗎？

身心障礙福利科洪科長筱涵：

會，勞政那邊會把他們接受服務的狀況回報給社會局。

李議員偉智：

科長，會後給我一些資料，10 萬人本身需要就業可是目前無法媒合到就業的數字還蠻多的，你知道嗎？我現在就針對這些數字問接下來要怎麼做？我很多個案是有缺陷，雖然工作能力沒問題，但是雇主就是不想聘用，這樣來來回回是浪費時間，這個問題我丟給局長跟科長之前，我自己也在想這件事情，如果找不到好的方法，我們可能要借鏡其他縣市看有沒有比較具體的做法，局長，你們想一下，我們會後再來討論一下，謝謝局長。

社會局盧局長禹璁：

好，謝謝。

身心障礙福利科洪科長筱涵：

好，謝謝。

李議員偉智：

就教衛生局李局長，早上很多同事提到健檢，你健檢的補助幾歲以上有糞便潛血的篩檢還有女性一些特殊篩檢等等這些都沒問題，請問現在健檢的人數比重大概多少？也就是已經到達優惠條件門檻有去做健檢的比例高嗎？有到 5 成嗎？

衛生局李局長翠鳳：

符合條件的追蹤率對嗎？

李議員偉智：

對。

衛生局李局長翠鳳：

符合條件的，其實我們每一年都有中央規定的標準，8 成以上。

李議員偉智：

好，那我就問你，如果有 8 成去健檢，那 B 肝跟 C 肝健檢的比例有多高？這個部分你完成了幾成？

衛生局李局長翠鳳：

B 肝跟 C 肝更高，應該有到 7 成，是全國第一名。

李議員偉智：

好，B 肝跟 C 肝還有你剛才講的 8 成健檢等數字是我們國家預防醫學很重要的數字，所以我等一下會接續問你一些數字背後延伸的問題你要怎麼再去處理。

衛生局李局長翠鳳：

好。

主席：（陳議員皇宇）

謝謝，請余杭青議員。

余議員杭青：

謝謝主席。我想請問一下我們的衛生局長，今年 8 月 1 日開始有一個 15 到 45 歲青壯世代心理健康支持方案，原本是 15 到 30 歲，後來因為有數據顯示 35 到 45 歲是憂鬱症、焦慮症等的好發年紀，我想請教一下，我們臺南市衛生局的官網上面哪邊可以預約得到？

衛生局李局長翠鳳：

目前我們有一個預約的專線電話，我們在很多平台上都有推播這個專線，他只要打電話進來且符合條件的話都是可以立刻協助的。

余議員杭青：

那當地衛生所有嗎？

衛生局李局長翠鳳：

衛生所應該也是透過這個專線來預約，預約的點很多，有 43 個點。

余議員杭青：

37 區有 43 個點，我看到你們工作業務會報上面有寫，有線上嗎？還是直接電話？

衛生局李局長翠鳳：

都可以，網路也都可以。

余議員杭青：

就是兩個管道，一個是電話一個是官網，那我們去到院所的時候是不是還要額外再收掛號費、行政費用或是會有一些相關的費用？

衛生局李局長翠鳳：

目前都不用。

余議員杭青：

要確定一下喔，這是中央的美意，但其實有些院所還是會收掛號費或是其他相關的行政費用，那民眾就會有疑慮，覺得支持他們去心理諮詢的方式為什麼還要收掛號費，這個部分請衛生局跟有配合的診所做說明，收費部分看要怎麼統一規定，不要這間收那間不收。

衛生局李局長翠鳳：

對，我們衛生所一定是都沒有收。

余議員杭青：

衛生所當然沒有收，但通常一個諮詢都要 6 次以上，一般診所 3 次期間滿了之後後面還要自費，這樣後續還會不會繼續去諮詢，其實也是一個很大的問題。我想請問局長，我們軍公教的人員每一年也有固定的心理諮商，好像有分級等嗎？

衛生局李局長翠鳳：

沒有，就是一年有 2 次。

余議員柷青：

沒有分級等嗎？

衛生局李局長翠鳳：

沒有分。

余議員柷青：

那這 2 次有包還在這 3 次裡面嗎？還是額外的？會有衝突嗎？

心理健康科陳科長月英：

這是額外的，不在這 3 次裡面。

余議員柷青：

所以市府的人員自己額外有 2 次？15 到 45 歲有 3 次？

衛生局李局長翠鳳：

對，那是中央補助的。

余議員柷青：

兩者不衝突？所以總共會有 5 次嘛。

衛生局李局長翠鳳：

對，假如是市府的人員的話。

余議員柷青：

好，基本上心理有問題的人其實不太敢踏出去，所以這個部分請地方多作宣導。

主席：（陳議員皇宇）

請郭鴻儀議員。

郭議員鴻儀：

謝謝主席。社會局長，有一個議題是關懷據點的部分，我們的普及率跟覆蓋率從數據上看起來雖然有 500 多個，但有一些區分布的不是很均勻，舉個例，歸仁區 21 個里只有 4 個關懷據點，安南區 50 幾個里只有 11 個關懷據點，到底是怎麼回事？覆蓋率為什麼會那麼不平均？

社會局盧局長禹璁：

我想影響關懷據點的設立有一個可能的因素是經費，可能嫌經費少，第二個是要看有沒有志工。

郭議員鴻儀：

科長，審計報告裡面也有點出這個問題，它的普及率不高，覆蓋率也不高，重點是像這樣的關懷據點，承辦業務的大部分都是志工，在整個業務上確實是非常繁雜，會不會因為這樣的狀況而退場？

長期照顧管理中心陳主任儷今：

目前比較多的確實是因為志工比較老化或者是志工的人數不足，我們目前 649 個里有 401 個據點，涵蓋率是 61%。

郭議員鴻儀：

但是它的普及、平均率不高，都集中在某一些區域，其他像歸仁區 21 個里只有 4 個據點！確實在整個關懷據點的營運上都會有一些這樣的問題，我希望我們去解決這樣的問題之下要考慮到，現在很多據點的資源是來自於地方一些企業的資源，到底我們政府是做到什麼程度？而且很多據點的幹部都一直在反映、抱怨乾脆不要做好了，做了麻煩又來了，有一些里長還要先墊錢，是不是？

長期照顧管理中心陳主任儷今：

目前我們的錢都採先預撥，確實相關經費是依中央補助基準，今年 113 年中央有調高，每個據點看它的天數有 1 萬 2,000 元到 6 萬元不等，確實經費上有不足。

郭議員鴻儀：

在整個業務的辦理上確實是有一些繁雜，一般的老人你要叫他去做這些資料真的是很難，審計處也點出這一個很大的問題，那未來怎麼去提升覆蓋率，我想這是我們社會局未來要去做的事。

社會局盧局長禹璁：

是。

主席：（陳議員皇宇）

請穎艾達利。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。衛生局局長，上午講的到宅牙醫這個部分，改善進度可能要麻煩你們有任何新的進度先知會一下。

衛生局李局長翠鳳：

好，沒問題。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

第二個部分就是針對 55 歲以上原住民這個部分的金額的調動，如果你們這邊有算出新的數據再給我。

衛生局李局長翠鳳：

好，沒問題。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

第三個部分比較重要，我個人覺得這可能是我這幾年會比較希望能促成推動的，大概內容也講過，總之就是有一些人不見得能夠一次性的去支付醫療費用，這些費用可能不是健保或其他保險可以處理的，它金額可能也不像大家想的 20 萬 30 萬 50 萬那麼大，可能只是 3 萬 5 萬，可是對他的家庭支出如果一定程度去負擔的話，會造成他自己經濟調配的困難，所以希望局端能跟中央爭取，是不是試試看來做一個醫療低率利貸款，由官股銀行來做這個作業，利息的部分就是由中央撥付金額支應，等於是讓患者或家屬可以用一個無息分期的方式去支付醫療費用，這一塊我聽局長說有跟中央反映過，不曉得現在的進度如何？

衛生局李局長翠鳳：

9 月 7 日中央在澎湖有召開一個衛生跟社會的衛社政會議，這當中的提案部長有裁示，請林靜儀次長必須去跟金管會進一步協調，在他們協調之後我們也會來追蹤進度，希望這個案子能夠成功。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

這個東西一旦能成功，我想不只臺南，我相信如果可以全國一併適用的話對全國幫助很大，但是這是我個人這樣想像的，也許透過衛生局這個醫政專業的地方也有別的做法，我覺得大家可以再討論，看怎麼把這件事情促成。就像我今天跟農業局在談那些沒有被納入天災給付的部分，希望是不是能用一個保險的方式來保障農民，我們協調很久，後來在農業局自己的發想之下，就從原本我所想的支出保險，後來變成收入保險，這個保險就這樣推動了，現在變成全國適用的東西，我相信這個東西的方向是沒有問題的，以全國的醫療預算來講的話，它的利息分擔的補助部分也不會太高，所以真的希望這個地方局長能跟局上的夥伴一起努力，看怎麼樣把這個來促成，好不好，謝謝你。

衛生局李局長翠鳳：

好，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

現在蔡筱薇、李宗霖跟朱正軒聯合質詢，請蔡筱薇議員先。

蔡議員筱薇：

謝謝主席，辛苦了。社會局盧局長，想要跟你討論的是復康巴士跟通用計程車的司機流程，要搭乘的人在登記上都很方便，針對司機的部分，可不可以說明一下現在司機的流程是怎麼處理？

身心障礙福利科洪科長筱涵：

目前駕駛的部分，會收到紙本的派車單，然後再依照紙本的派車單讓民眾實際搭車的時候簽名，然後再回收這個紙張。

蔡議員筱薇：

好，所以紙張回收的部分是要司機送回去，對不對？那我們有沒有辦法把紙本減量，然後變成是電子化、數位化的，可以嗎？

身心障礙福利科洪科長筱涵：

有，我們目前其實已經找了廠商來看現在系統的頁面，目前就是在做系統的開發。

蔡議員筱薇：

要多久時間？

身心障礙福利科洪科長筱涵：

我們目前的規劃是希望可以在明年朝向數位化跟無紙化，因為它所有的跳表機都要換掉，所以我們還是要考量一下，不要影響到民眾搭車的權益。

蔡議員筱薇：

當然，司機在載運的過程當中，我們要簡化回繳時間的浪費，希望可以做這樣的優化，也希望可以趕快完成，你們今年就有編預算了嗎？

身心障礙福利科洪科長筱涵：

今年度沒有這一筆預算，明年度我們會在爭取看看。

蔡議員筱薇：

這有沒多少錢，為什麼不要今年編一編？

身心障礙福利科洪科長筱涵：

這個預算我們算過，那時候估價起來要 350 萬，今年的預算的確沒有容納的空間。

蔡議員筱薇：

好，總質詢的時候我來跟市長爭取，我覺得這個可以趕快優化的話是方便大家，方便司機，也方便搭載的人，謝謝。

社會局盧局長禹璁：

是，謝謝議座。

身心障礙福利科洪科長筱涵：

謝謝議座。

蔡議員筱薇：

好，局長請坐。衛生局李局長，有關於老舊社區的登革熱防治的部分，之前也有大概跟局長提過這件事，地方上有一些是舊式的社區大樓，甚至連管委會都還沒成立，它的地下室很多幾乎都是有積水的狀況，狀況好一點的是住戶還能接受，一般地下室的就讓魚在那邊游並吃掉子孓或者是投藥。但是有些狀況是這樣的，我那天有拜託我們同仁來到現場，右手邊兩張照片可以很明顯的看出堆放很多雜物，那個地方是公共空間，可是持有人就秉持著公共空間他占有一部分、千分之一或百分之一的理由，所以他把他的東西繼續放在那，但是因為沒有登革熱，所以你沒有辦法強制要求他要把這些東西清走，且遇到的困難就是他不承認東西是他的，希望局長看看這件事情能怎麼處理，我覺得這個東西還是要把他移除掉，不能讓他繼續在那邊，謝謝。

衛生局李局長翠鳳：

好，收到。

李議員宗霖：

謝謝蔡筱薇議員跟朱正軒議員。衛生局李局長，我們早上在討論護病比的標準，你有提到我們很多的護理師或者是醫院的員工比較會有一些勞工上面的爭議，尤其是2024年的5月，。衛服部提出的人力政策整備的12項計畫裡面，涉及勞基法的有1,500多件，所以這個部分要拜託你跟勞工局合作，像是假日上班、工時過長等等部分要請你們多加注意，不然我們的目標訂的在怎麼漂亮，可是我們醫護人員的勞動條件沒有變好的狀況之下，其實還是相對困難，好不好？

衛生局李局長翠鳳：

好。

李議員宗霖：

另外有一個東西要拜託你們去提醒，我最近注意到一個失智年輕化的新聞，你們對於本市失智症的就醫人口狀況有沒有掌握？是不是有年輕化的趨勢？

衛生局李局長翠鳳：

目前臺南市主要篩檢的對象是65歲以上,所以年輕的族群我想我們健保這邊要跟他們比對一些資料，年輕族群這一塊，科長有沒有要補充?

國民健康科黃科長琬淇：

因為目前我們目前在行動醫院做篩檢，也是針對65歲以上的長者來做篩檢。

李議員宗霖：

我們現在有一些文明病，會造成失智年輕化我看到的時候也嚇到，這個部分要拜託局處在宣導的時候不只是中高的年齡層，年輕的年齡層，有機會的話在各大場合也要請大家多注意，在未來他們年紀漸長的時候，也比較不會造成我們後續的醫療負擔。

衛生局李局長翠鳳：

是。

李議員宗霖：

謝謝局長，請坐。盧局長，我們老年人口的居住宅數目越來越多，我要請你注意的部分就是孤獨死的這一塊，孤獨死的這一塊，你們有掌握臺南市的數據方面嗎？沒關係，這個部分要拜託你們，其實我認為我們民政局的系統還算蠻強的，不管是社區的防護或是鄰里的部分算是蠻堅強的，所以這個部分要麻煩你們跟民政局加強鄰里的處理，來防止孤獨死的狀況發生。

社會局盧局長禹璁：

是。

朱議員正軒：

謝謝蔡筱薇議員跟李宗霖議員，早上的問題再次就教社會局長，局長，我們跟 NCC 確認過，如果就這個新聞來講的話，他其實有提到說是因為 3G 手機沒辦法通訊，跟 NCC 查核確實 3G 部分的地區已經停止服務了，所以確實會造成他沒有辦法撥打 110 的狀況，所以局長，我們是不是可以要求以後申請設置托嬰中心或是相關托嬰場所的時候，要把通訊設備納為檢驗的必備標配？

社會局盧局長禹璁：

是，如果是這樣的話，首先我覺得在我們設置的時候，通訊設備應該是列為必備可通之一。

朱議員正軒：

所以在申請設置的時候，就會檢核這個項目嗎？

社會局盧局長禹璁：

對，就應該要檢核。第二，就是 SOP 一定要再做強化。

朱議員正軒：

好，局長謝謝。再來要就教衛生局，衛生局局長，我們今天早上有提到外縣市有很多這樣的做法，我知道我們臺南市也有，那未來怎麼把我們這個已經做得很好的臺南共照雲推廣普及，讓更多人一起使用？

衛生局李局長翠鳳：

我剛剛也跟主秘在討論，其實我們有很多據點已經做得非常好，後續我們會來辦一個記者會，我們想要實際的從個案看怎麼樣來接受這個 AI 的檢測，然後資料數據怎麼樣進到我們的共照雲，在我們的共照雲裡面甚至可以結合後續的醫療等等，我想我們會讓更多人知道跟了解，其他管道我們也會做。

朱議員正軒：

是，所以這個記者會其實我們也會選定幾個比較有成果的示範社區嘛？

衛生局李局長翠鳳：

對。

朱議員正軒：

未來我們量測血壓就不是只寫在紙本上面，而是把所有的資料上傳到雲端，這樣有兩個好處，第一個是我們在擬定公衛政策的時候會有大數據參考，第二是個案本身如果出現一些警訊的話，第一時間這些遠端的智慧醫療就可以進駐來服務了。

衛生局李局長翠鳳：